

BN, BED, AN — *jeden rdzeń, trzy fenotypy*

Bulimia, zaburzenie z napadami objadania, anoreksja — wspólny rdzeń poznawczy, różne fenotypy zachowaniowe. Leczenie częściowo podobne, częściowo specyficzne.

CZAS: 20 min · diagnostyka różnicowa · Sesja diagnostyczna · planowanie leczenia

ŹRÓDŁO: Fairburn & Harrison (2003); DSM-5 (APA 2013); ICD-11 (WHO 2019)

JAK UŻYWAĆ

Zobacz **trzy główne zaburzenia odżywiania** i ich różnice (sekcja 1), poznaj **kluczowe wymiary różnicujące** (sekcja 2). W sekcji 3 — **OSFED** jako kategoria między formami. Sekcja 4 — Twoja konsultacja.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Fairburn & Harrison (2003): wszystkie ED mają **wspólny rdzeń poznawczy** (nadmierne znaczenie wagi/kształtu), ale różne fenotypy zachowaniowe. BN — epizody + kompensacja; BED — epizody bez kompensacji; AN — restrykcja, niski BMI. Konsekwencja: **części leczenia są wspólne** (rdzeń, regularne jedzenie), ale każde wymaga modyfikacji. Diagnostyka różnicowa jest **kluczowa** dla planowania: AN — program specjalistyczny z monitoringiem somatycznym; BN i BED — głównie psychoterapia ambulatoryjna (CBT-E). Pacjenci często „migrują” między diagnozami: 30–50% osób z AN rozwija BN.

01 Trzy zaburzenia — porównanie

WYMIAR	BULIMIA (BN)	BED	ANOREKSJA (AN)
Epizody objadania	Tak, $\geq 1 \times$ /tydz.	Tak, $\geq 1 \times$ /tydz.	Nie (typ restr.) / Tak (typ binge-purge)
Kompensacje	Tak — wymioty, środki, ćwiczenia	Nie	Restrykcja + czasem kompensacja (BP)
Masa ciała	Zwykle w normie lub nadwaga	Często nadwaga / otyłość	Istotnie niska (kryterium AN)
Rdzeń (overvaluation)	Tak (wymagane)	Często, ale nie wymagane	Tak — z lękiem przyrostu masy
Leczenie pierwsze	CBT-E, IPT-BN	CBT-E, IPT	Specjalistyczny program; FBT (młodzież)

02 Kluczowe wymiary różnicujące

CZY SĄ KOMPENSACJE

Kluczowy wymiar BN vs BED. Kompensacje (wymioty, środki, ćwiczenia, głódówka „na pokutę”) odróżniają BN od BED.

CZY JEST ISTOTNIE NISKA MASA

Kluczowy wymiar AN. „Istotnie niska” — nie konkretna liczba, lecz znacząca dla wieku, płci, rozwoju. Wymaga oceny medycznej.

CZY SĄ EPIZODY UTRATY KONTROLI

Subiektywne lub obiektywne. Charakterystyczne dla BN, BED, AN-BP. AN-typ restrykcyjny — bez epizodów.

MIGRACJE MIĘDZY DIAGNOZAMI

30–50% osób z AN rozwija BN w ciągu życia. Część osób z BN przechodzi w BED po remisji wymiotów. Diagnostyka może się zmieniać.

03 📄 OSFED — między formami

Wielu pacjentów nie spełnia wszystkich kryteriów żadnej z trzech głównych diagnoz, ale ma **klinicznie istotne** objawy. Ta kategoria — *Other Specified Feeding or Eating Disorder* (OSFED) — obejmuje około 50% wszystkich klinicznych ED. *Nie* jest „lżejsza forma” — wymaga takiego samego leczenia.

ATYPOWA AN

Wszystkie kryteria AN, ale BMI nie poniżej progu. Pacjenci o normalnej lub wyższej masie z pełnym mechanizmem AN.

ATYPOWA BN

Wszystkie kryteria BN, ale niższa częstotliwość (1×/2 tyg.) lub krócej niż 3 mies. Mechanizm identyczny.

ZACHOWANIA OCZYSZCZAJĄCE BEZ OBJADANIA

Wymioty / środki po *normalnych* posiłkach (bez epizodu). Wysokie ryzyko somatyczne, niska rozpoznawalność.

NIGHT EATING SYNDROME

Nocne / wieczorne epizody jedzenia z budzeniami. Często współwystępuje z BN. Własny rytm dobowy.

04 ✎ Moja konsultacja — pytania do specjalisty

KTÓRE ELEMENTY Z TABELI ROZPOZNAJĘ U SIEBIE

— epizody, kompensacje, restrykcja, lęk o masę

PYTANIA DO DIAGNOSTY

— co warto wyjaśnić; co mnie niepokoi

Klucz: diagnoza różnicowa nie służy **etykietowaniu**, lecz **planowaniu leczenia**. BN i BED leczy się głównie ambulatoryjnie (CBT-E, IPT-BN), AN — często wymaga programu specjalistycznego, czasem hospitalizacji ze względu na ryzyko somatyczne. *Migracja* między diagnozami nie jest porażką — to **dynamika** zaburzenia, którą można obserwować i adresować. Fairburn (2008): *transdiagnostyczne* podejście CBT-E działa skutecznie we wszystkich kategoriach ED u dorosłych — to argument za jego elastycznością. Jeśli rozpoznajesz u siebie elementy *kilku* diagnoz — to nie znaczy, że nie wiesz, „co masz”, tylko że Twój obraz jest *złożony*. Profesjonalna konsultacja diagnostyczna pomoże ustrukturyzować plan leczenia. Pierwszy krok — kontakt z poradnią zaburzeń odżywiania lub specjalistą.